

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE COIMBRA
Diário Clínico
Consulta Externa
15-11-2025 09:30
Dr(a). Judy Paulo (HUC-ONCOLOGIA MÉDICA MAMA)

47 anos, sexo feminino
Diagnóstico: Carcinoma mamário invasor NST G3, mama esquerda
Estadiamento: cT2N1M0 – estadio IIIA
Perfil molecular: ER-, PR-, HER2 0, PD-L1 CPS 15, NGS sem mutações acionáveis, teste genético BRCA1/2 negativo
Comorbidades: Hipotireoidismo (levotiroxina 100 µg id)

História da Doença Atual

Nódulo mamário esquerdo palpável detectado em maio 2025, associado a astenia grau 1. PET-CT de 20-06-2025 demonstrou lesão mamária esquerda hipermetabólica com adenopatias axilares homolaterais, sem sítios metastáticos à distância. Biópsia de 15-06-2025 confirmou carcinoma invasor NST G3, Ki-67 70%. Iniciou neoadjuvante Paclitaxel semanal + Carboplatina (AUC 5) em 01-07-2025, seguido de AC (doxorubicina + ciclofosfamida) até 01-11-2025. Durante o ciclo 4 de Paclitaxel apresentou neutropenia G2, atrasado 1 semana; eventos de toxicidade incluíram epistaxe leve e alopecia difusa.

Peso 62 kg, pressão arterial 118/72 mmHg, ECOG-ps 0.
Hemograma de 10-11-2025: neutrófilos $1,8 \times 10^9/L$ (G2), hemoglobina 13,2 g/dL, plaquetas $250 \times 10^9/L$.
RM mamária bilateral de 12-11-2025 mostra redução do tamanho da lesão primária (de 2,5 cm para 1,8 cm) e diminuição da intensidade de realce nas adenopatias axilares, sem sinais de invasão de pele ou músculo. PET-CT de seguimento ainda não realizado.

Avaliação

Doente em bom estado geral, sem queixas significativas além de alopecia em curso. Não há sinais de progressão clínica ou radiológica. Toxicidades da quimioterapia resolvidas; neutropenia estabilizada, epistaxe cessada. Função tireoidiana controlada (TSH 2,1 mU/L).

Plano de Tratamento

Encaminhamento para cirurgia conservadora da mama esquerda com esvaziamento axilar completo, a ser realizado em 08-12-2025. Pedido de marcação de clip mamário pré-operatório e de avaliação pré-anestésica. Discussão multidisciplinar (oncologia, cirurgia mamária, radiologia) confirmada em reunião de 14-11-2025; decisão de manter abordagem conservadora dado bom resposta ao neoadjuvante e ECOG-PS 0. Iniciar suplementação de ferro oral por anemia leve (Hb 12,8 g/dL) até data da cirurgia.

Seguimento

Consulta de controle pós-cirúrgico agendada para 01-02-2026, com avaliação de margens histológicas, necessidade de radioterapia adjuvante e possível inclusão de imunoterapia de manutenção (pembrolizumabe) caso patologia confirme alto índice de PD-L1. Repetir PET-CT de 6 meses após cirurgia para estadiamento definitivo.

Observações

Paciente informa boa adesão ao tratamento, apoio familiar e disponibilidade para deslocamentos. Não há contraindicações para cirurgia. Manter levotiroxina 100 µg id, controlar pressão arterial e monitorizar hemograma antes de cada ciclo de quimioterapia restante.

TC TAP 03-09-2025:
lesão mama E 2,4 cm
adenopatias axilares 12 mm

sem metastização evidente

Sem febre.
ECOG 0.

Discutido em reunião multidisciplinar.
Pedido enviado à CFT.

Processado por computador - SClínico
Pag. 1/1